内科学含诊断学 风湿系统疾病

① 核心精讲·系统性血管炎

（性感认识：糖皮质激素+免疫抑制剂）SLE、干燥综合征(有内脏损害)

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

类风湿:同服NSAIDs或糖皮质激素+改善病情抗风湿药DMARDs

干燥综合征(无内脏损害):西维美林、毛果芸香碱等对症

一、分类

表 8-6-1　2012 年 Chapel Hill 会议制定的血管炎分类

累及大血管的系统性血管炎	单器官血管炎
大动脉炎、巨细胞动脉炎 巨大	皮肤白细胞破碎性血管炎
累及中等大小血管的系统性血管炎	皮肤动脉炎
结节性多动脉炎、川崎病	原发性中枢神经系统血管炎
累及小血管的系统性血管炎	孤立性主动脉炎
ANCA 相关血管炎（AAV）	与系统性疾病相关的血管炎
显微镜下多血管炎	红斑狼疮相关血管炎
肉芽肿性多血管炎 wegener肉芽肿	类风湿关节炎相关血管炎
嗜酸性肉芽肿性多血管炎	结节病相关血管炎
免疫复合物性小血管炎	与可能病因相关的血管炎
抗肾小球基底膜病	丙肝病毒相关冷球蛋白血症性血管炎
冷球蛋白性血管炎	乙肝病毒相关血管炎
IgA 性血管炎	梅毒相关主动脉炎
低补体血症性荨麻疹性血管炎	血清病相关免疫复合物性血管炎
☆☆☆ 累及血管大小可变的系统性血管炎	药物相关性免疫复合物性血管炎
贝赫切特病、科根综合征 有大有小	药物相关 ANCA 相关血管炎
	肿瘤相关血管炎

二、检查

② 1.**抗中性粒细胞胞质抗体 ANCA**：小血管炎

①**p-ANCA、MPO-ANCA：显微镜下多血管炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎**

②**c-ANCA：肉芽肿性多血管炎**/Wegener 肉芽肿（鞍鼻、咯血）伟哥在厕所流鼻血 WC

2.抗内皮细胞抗体 AECA 内皮 特异性不大

①多种血管炎：大动脉炎、川崎病、贝赫切特病

②非血管炎

③ 3.**金标准：病理活检**

VS 肺血栓栓塞症首选CTPA,金标准肺动脉造影

4.了解病变范围最佳：血管造影（大、中血管炎）小血管炎看不见

三、显微镜下多血管炎

1.表现 继发I型急进性肾炎:goodpasture综合征 继发III型急进性肾炎:SLE、过敏性紫癜,急性肾炎

①肾受累：血尿、蛋白尿、肾功能不全等，几乎无 ttsx 免疫复合物沉积（**继发III型急进性肾炎**）

②皮肤黏膜（口腔溃疡）、周围神经、肺受累（**咯血**）咯血未必是I型急进性肾炎,也可为III+III型

一个风湿系统疾病有口腔溃疡有什么奇怪的呢?

I型(抗GBM抗体)和III+III型(三型ANCA无免疫)通过抗体去鉴别

2.治疗：**糖皮质激素+免疫抑制剂（环磷酰胺等）**。CD20 单克隆抗体**利妥昔单抗**为一线治疗

二美丽　美罗华

① **理顺概述:**

血管炎是指病理上以血管壁炎症为特征的一组炎性自身免疫病,系统性血管炎是指累及多个脏器的血管炎。

② **理顺抗体:**

自身抗体在血管炎发病中起重要作用,其中最重要的是抗中性粒细胞胞质抗体ANCA。

ANCA是第一个被证实参与血管炎发病的自身抗体,其靶抗原为中性粒细胞胞质内的多种成分,如丝氨酸蛋白酶3/PR3、髓过氧化物酶MPO、弹性蛋白酶、乳铁蛋白等,其中PR3和MPO是主要的靶抗原。

有两种测定ANCA的方法,即间接免疫荧光法和酶联免疫吸附试验(ELISA)。间接免疫荧光检查中,中性粒细胞胞质呈荧光阳性则称为C-ANCA阳性,当中性粒细胞的细胞核周围呈荧光阳性时,则称为P-ANCA阳性。

ELISA法测定时若呈PR3抗体阳性,即PR3-ANCA阳性,ELISA法测定时若呈MPO抗体阳性,即MPO-ANCA阳性。

ANCA与小血管炎相关,如C-ANCA与肉芽肿性多血管炎相关,P-ANCA与显微镜下多血管炎和嗜酸性肉芽肿性多血管炎相关,因此将这三类血管炎统称为ANCA相关血管炎。

③ **理顺病理活检:**

活检是确诊血管炎的"金标准",即血管壁炎症细胞浸润,纤维素样坏死,肉芽肿形成,血管管腔狭窄、闭塞、血栓形成等都支持血管炎的诊断;而血管壁的纤维素样坏死是其特征性的病理改变(串联:病理学中纤维素样坏死多见于"高(急进型高血压)风(风湿)亮(新月体性肾炎、重症急性肾炎)节(结节性多动脉炎)、喂(胃溃疡)狼(SLE)超(超急性排斥反应)糖(I型糖尿病)")。

但值得注意的是,由于血管炎的病理改变可呈现节段性,因此组织活检未见到血管壁炎症,也不能排除血管炎的诊断。

四、贝赫切特病/白塞病

1.累及血管大小可变（大宝贝小宝贝）④

2.表现（口生眼红刺）重要

①反复口腔溃疡：最主要、首发（必看主诉）、诊断最基本和必需 痛

②反复外阴溃疡 VS SLE口腔溃疡不痛

③葡萄膜炎/虹膜睫状体炎、视网膜血管炎

④皮肤结节性红斑、痤疮样皮疹、浅表栓塞性静脉炎

⑤肠白塞（右下腹痛多见）、膝关节痛

⑥针刺反应 针刺后患者局部出现红肿化脓

注意：白塞病、类风湿少见肾受累（败类没有肾）

VS：肾多受累的SLE（肾小球）、显微镜下多血管炎（肾小球）、干燥综合征（肾小管） 常继发IIII型急进性肾炎

表 8-6-3　国际白塞病诊断标准

体征/症状	评分
眼病	2
生殖器阿弗他溃疡	2
口腔阿弗他溃疡	2
皮肤病变	1
神经系统表现	1
血管表现	1
针刺试验阳性*	1

注：*针刺试验为可选项。口腔阿弗他溃疡：指每年至少有3次肯定的口腔溃疡。生殖器阿弗他溃疡：指经医师确诊或本人确有把握的外阴溃疡。眼病：包括前葡萄膜炎、后葡萄膜炎、视网膜血管炎、裂隙灯显微镜下的玻璃体内有细胞出现。皮肤病变：包括结节性红斑、假性毛囊炎、丘疹性脓疱疹，未用过糖皮质激素、非青春期者出现的痤疮样结节等。

3.治疗

①累及内脏和眼炎：糖皮质激素+免疫抑制剂

②沙利度胺：口腔溃疡。孕妇禁用（可致海豹胎畸形）渡口-海

③秋水仙碱：防止结节性红斑、生殖器和口腔溃疡复发的首选（秋后算账）

专题串联·糖皮质激素

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

结核毒血症状很重时,在有效抗结核药前提下用GC

严重感染

慢性气道炎症 E组(高风险)、急性加重住院

支气管哮喘、COPD、间质性肺病 特发性肺间质纤维化急性加重时用GC/过敏性肺炎直接用GC

A 型慢性萎缩性胃炎、炎症性肠病 免疫问题

急进性肾炎、肾病综合征 自己吸激

最佳依库珠单抗(对抗补体) 激球 VD、RD、MVP VP、DVP、DVLP

再障、PNH、温抗体自免溶、ITP、骨髓瘤、NHL、ALL、M_3用 ATRA 出现分化综合征

CHOP 全身炎症反应综合征

甲危、Graves 眼病活动期、库欣综合征 激素怎么补看肾上腺怎么切

风湿系统疾病

过敏性休克

运动系统慢性损伤（除开髌骨软骨软化症-不利软骨修复、胫骨结节骨软骨病-骨骺难以注入。相敬如宾）

真题解析·系统性血管炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2018N91-92 A 女性，25 岁，1 周来无明显诱因发热、双膝关节疼痛伴皮肤出血点，自测体温最高 38.8℃，无寒战。既往体健。查体：T 38.1℃，四肢皮肤可见出血点，口腔黏膜见两处溃疡。心、肺、腹无明显异常，化验血：Hb 102g/L，WBC 5.2×10^9/L，Plt 24×10^9/L，网织红细胞 4.9%，尿蛋白(++)。

91.该患者最可能诊断为 白塞病口腔溃疡必须放主诉

A.再生障碍性贫血

B.急性肾小球肾炎

④理顺白塞病/贝赫切特病BD:

①.BD的病理改变为血管炎,受累部位的血管壁有炎症细胞浸润、管壁增厚、管腔狭窄,严重者有血管壁坏死、血管瘤形成,可以见到继发性血栓形成。
但与其他血管炎不同的是,本病可以累及大、中、小及微血管,且动静脉均可受累。

②.临床表现:

❶.口腔溃疡:反复发作为特点,在颊黏膜、舌缘、唇、软腭等处出现不止一个的痛性溃疡,且症状见于98%以上的患者,为BD的首发症状,是诊断本病最基本而必需的症状。即反复痛性口腔溃疡作为首发症状,是诊断最基本和必需的症状。

❷.外阴溃疡:见于约80%的患者,与口腔溃疡的性状基本相似。常出现在女性患者的大、小阴唇,其次是阴道;在男性则多见于阴囊和阴茎,也可出现在会阴或肛门周围。

❸.眼炎:最常见的眼部病变是葡萄膜炎及由视网膜血管炎造成的视网膜炎,眼炎的反复发作可导致视力障碍甚至失明。

❹.皮肤病变:呈结节性红斑、痤疮样皮疹、浅表栓塞性静脉炎等不同表现,以结节性红斑最为常见,多见于膝以下部位,呈对称性,表面呈红色浸润性皮下结节,有压痛,分批出现,逐渐扩大。

❺.系统性症状:如消化道受累称为肠白塞病(大多出现在病情活动患者,按症状出现频率,最多见的是腹痛,以右下腹痛为常见。消化道的基本病变是多发性溃疡,可发生在自食管至降结肠的任何部位。
如关节痛见于30~50%的患者,表现为单个关节或少数关节的痛、肿,甚至活动受限。其中以膝关节受累最多见。大多数仅表现为一过性的关节痛,可反复发作,呈自限性。

❻.针刺反应:是BD病目前唯一的特异性较强的实验。即消毒皮肤后用无菌针头在前臂屈面中部刺入皮内然后退出,48h后观察针头刺入处的皮肤反应,局部若有红丘疹或红丘疹伴有白疱疹则视为阳性结果。
值得注意的是BD患者在接受静脉穿刺检查或肌内注射治疗时,也会出现针刺反应阳性。

C.系统性红斑狼疮 多系统损害
D.贝赫切特（Behcet）病
92.为明确诊断，查体中还需特别注意检查
A.颜面部水肿
B.盘状红斑
C.结节状红斑
D.牙龈渗血

2.2019N91-92 A 女性，31 岁。主诉 反复口腔溃疡伴间断双膝关节游走性肿痛 1 年，近 1 周自觉左眼视物不清，并出现间断下腹痛。
91.该患者最可能的诊断是
A.风湿热
B.系统性红斑狼疮
C.类风湿关节炎
D.贝赫切特（Behcet）病
92.该病特异性的皮肤表现是
A.盘状红斑
B.结节性红斑
C.类风湿结节
D.环形红斑

3.2021N55 A 贝赫切特病的特异性临床表现是
A.颊部蝶形红斑
B.腮腺肿大
C.针刺反应
D.腹部血管杂音

4.2021N56 A 下列属于 ANCA 相关血管炎的疾病是
A.IgA 血管炎
B.显微镜下多血管炎
C.红斑狼疮相关血管炎
D.类风湿关节炎相关血管炎

5.2021N91-92 A 女性，50 岁。口干、乏力 1 年。加重伴夜尿增多 1 个月（累及肾小管,导致浓缩功能↓），既往体健。查体：舌面干燥，口腔颊黏膜见数处小溃疡，多发龋齿，多个残留黑色牙根。血 ESR 84mm/h，ANA 1:160 阳性，抗 SSA 抗体阳性。dsDNA抗体阳性 选C
91.该患者最可能的诊断是（原发性）
A.干燥综合征
B.多发性骨髓瘤
C.系统性红斑狼疮
D.贝赫切特病
92.以下病变中，该病最常出现的是
A.肾小球病变

答案：2-5 DB C B AB

B.肾小管酸中毒
C.病理性骨折
D.消化道多发溃疡并出血

6.2023N91-92 A 男性，42 岁。间断口腔溃疡 5 年，偶有阴囊溃疡，反复左侧眼炎 3 年，近 1 周自觉左眼视物不清。
91.最可能的诊断是
口生眼红刺
A.系统性红斑狼疮
B.赖特（Reiter）综合征
C.克罗恩病
D.贝赫切特（Behcet）病
92.该病较常见的其他临床表现是
A.尿道烧灼感
B.盘状红斑
C.结节性红斑
D.心脏扩大

以题带动
知识点复习

7.2024N91-92 A 女性，26 岁。反复口腔黏膜溃疡半年，发热、双手及足关节痛 1 周。既往体健。查体：T 38.8 度，上肢皮肤可见出血点，口腔左侧颊黏膜可见一处溃疡，关节无红肿。血常规：Hb 118g/L，WBC 4.2×10^9/L，Plt 25×10^9/L。血 RF 阳性，ANA 滴度增高，抗 Sm 抗体阳性。
91.最可能的诊断是
A.类风湿关节炎
B.贝赫切特（Behcet）病
C.原发免疫性血小板减少症
D.系统性红斑狼疮
92.对该患者应首选的治疗是
A.对症治疗
B.应用糖皮质激素
C.应用丙种球蛋白
D.应用非甾体抗炎药

思维导图·系统性血管炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄